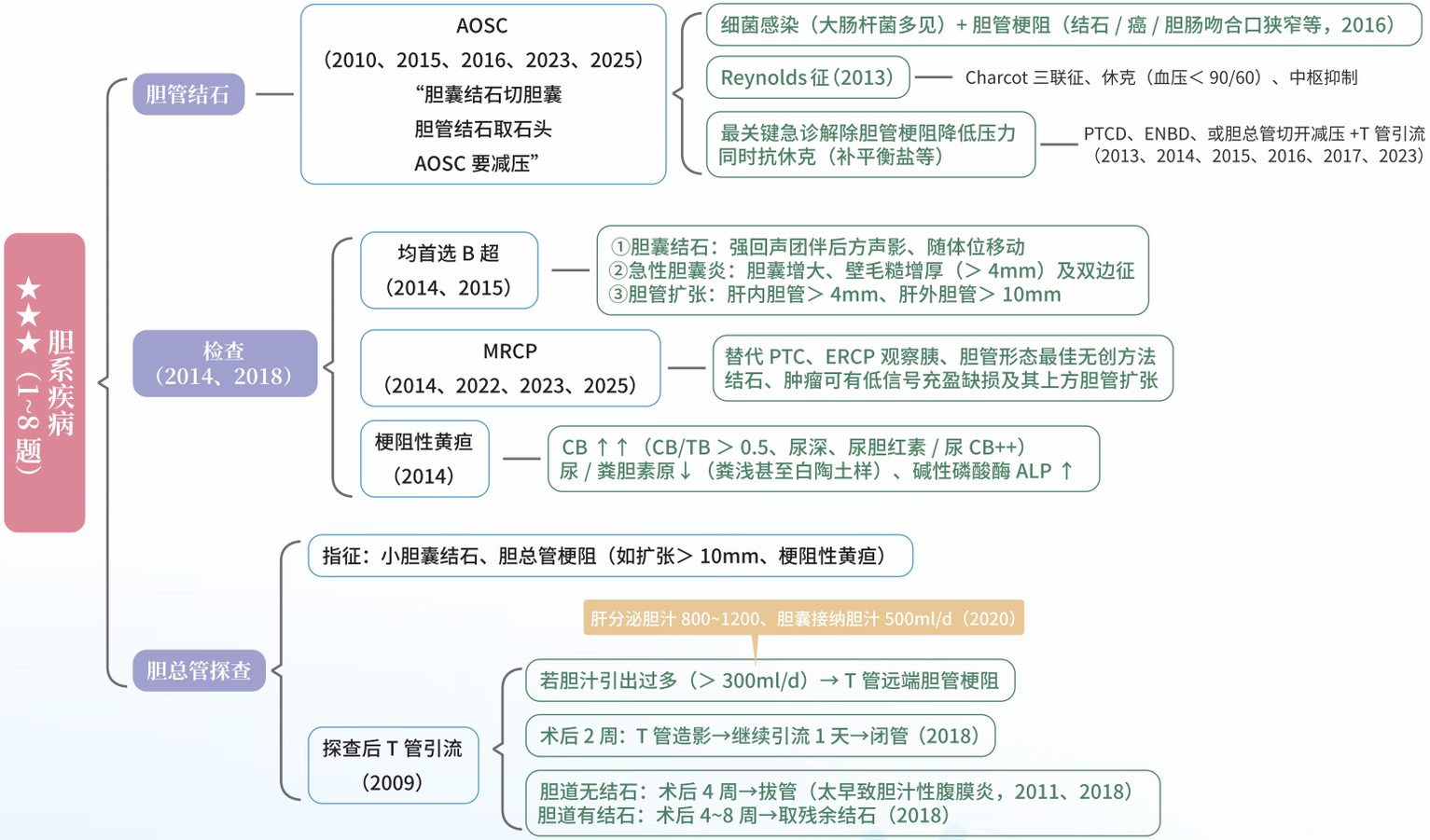

★★★胆系疾病（1~8题）
胆管结石
AOSC
（2010、2015、2016、2023、2025）
“胆囊结石切胆囊
胆管结石取石头
AOSC 要减压”
细菌感染（大肠杆菌多见）+ 胆管梗阻（结石 / 癌 / 胆肠吻合口狭窄等，2016）
Reynolds 征（2013）
Charcot 三联征、休克（血压＜ 90/60）、中枢抑制
最关键急诊解除胆管梗阻降低压力
同时抗休克（补平衡盐等）
PTCD、ENBD、或胆总管切开减压 +T 管引流
（2013、2014、2015、2016、2017、2023）
检查
（2014、2018）
均首选 B 超
（2014、2015）
①胆囊结石：强回声团伴后方声影、随体位移动
②急性胆囊炎：胆囊增大、壁毛糙增厚（＞ 4mm）及双边征
③胆管扩张：肝内胆管＞ 4mm、肝外胆管＞ 10mm
MRCP
（2014、2022、2023、2025）
替代 PTC、ERCP 观察胰、胆管形态最佳无创方法
结石、肿瘤可有低信号充盈缺损及其上方胆管扩张
梗阻性黄疸
（2014）
CB ↑↑（CB/TB ＞ 0.5、尿深、尿胆红素 / 尿 CB++）
尿 / 粪胆素原↓（粪浅甚至白陶土样）、碱性磷酸酶 ALP ↑
胆总管探查
指征：小胆囊结石、胆总管梗阻（如扩张＞ 10mm、梗阻性黄疸）
探查后 T 管引流
（2009）
肝分泌胆汁 800~1200、胆囊接纳胆汁 500ml/d（2020）
若胆汁引出过多（＞ 300ml/d）→ T 管远端胆管梗阻
术后 2 周：T 管造影→继续引流 1 天→闭管（2018）
胆道无结石：术后 4 周→拔管（太早致胆汁性腹膜炎，2011、2018）
胆道有结石：术后 4~8 周→取残余结石（2018）